

29 - 02-Révision de la séméiologie respiratoire 2ème séance (Teams)

- Pr A. BENJELLOUN

C'est une gêne respiratoire, dont se plaint le sujet, dont il va vous dire, je suis essoufflé, je le souffle court, je suis bloqué, j'ai du mal à respirer, il y a de la neige, il y a de la surfa, d'accord ? Et c'est un motif de consultation présent, euh, fréquent, pardon. Alors, ce qu'on a disposé, en fait, l'a disposé, c'est quand vous faites un effort, un grand effort respiratoire, mais il y a une récompense par rapport à votre effort. C'est comme si vous travailliez toute la journée pour quelqu'un, et à la fin de la journée, il va vous donner 20 dirhams.

La dyspnée, c'est la même chose. Vous faites un grand effort respiratoire, et à la fin, vous avez eu toute petite respiration, et c'est cette sensation, cette petite récompense qui définit la dyspnée, d'accord ? C'est une récompense d'un grand effort. Il y a plusieurs chémorécepteurs, ça, on l'a vu en physiologie, d'accord ? Je ne vais pas revenir là-dessus.

Toute modification de ces récepteurs, que ce soit des chémorécepteurs ou des mécanorécepteurs, peut entraîner une dyspnée. Alors, il y a plusieurs dyspnées. Vous allez le voir, il y a des dyspnées avec signe de lutte et des dyspnées sans signe de lutte.

Avec signe de lutte, on va le voir tout à l'heure. Maintenant, on va voir les dyspnées sans signe de lutte. Il faut savoir que le contenu artériel en oxygène, c'est la saturation.

Il dépend de la saturation et du taux d'hémoglobine. Le transport artériel, c'est le contenu artériel qui multiplie le débit cardiaque. Donc, dans les dyspnées sans signe de lutte respiratoire, ça dépend du débit cardiaque, donc c'est une maladie du cœur, la désaturation et l'hémoglobine.

Donc, il faut chercher une de ces trois étiologies. On le lit souvent. Dyspnée avec signe de lutte, c'est une obstruction.

Sans signe de lutte, il faut chercher l'une de ces trois anomalies, d'accord ? Retenez, le cœur, la saturation et l'hémoglobine. Ça, c'est une méthode qui va vous faire apprendre la grande majorité des étiologies des dyspnées et vous apprendre à raisonner. Donc, vous avez soit une origine mécanique, c'est les mécanorécepteurs qui vont être stimulés avec une augmentation du travail ventilatoire, trouble obstructif, ou une diminution des capacités ventilatoires, trouble obstructif.

Ou bien vous avez l'origine hypoxique, c'est les chémorécepteurs à l'hypoxie. Donc, soit altération de la saturation, soit atteinte de l'hémoglobine, une anémie ou une intoxication, soit une atteinte du débit cardiaque. Et puis après, vous avez l'acidose, c'est des récepteurs, des chémorécepteurs alliés au percapni et au pH.

Là, il y a différents termes qu'il faut connaître. Vous avez là le volume minute, c'est le volume courant qui multiplie la fréquence respiratoire. C'est ce qu'on a vu en physiologie.

Et là, il y a un certain nombre de termes qu'il faut connaître. La respiration normale, c'est 12 à 16 cycles par minute. La pnée, c'est l'arrêt respiratoire.

La brachypnée, c'est un ralentissement du rythme respiratoire. Donc, la fréquence respiratoire, elle est basse. La tachypnée, c'est une augmentation du rythme respiratoire.

D'accord ? C'est un allongement. Donc, c'est une tachypnée, c'est rapide. L'hyperpnée, c'est l'augmentation de la ventilation minute.

Ça veut dire que c'est soit augmentation de la fréquence, soit augmentation du volume courant. C'est l'hyperpnée. L'hypopnée, c'est une diminution du volume courant.

La polypnée, c'est une respiration rapide, mais superficielle. C'est-à-dire que la fréquence respiratoire est haute, mais le volume courant est bas. L'orthopnée, c'est quand vous avez une dyspnée ou dégubitus.

Et la platypnée, c'est l'inverse. C'est quand vous avez une dyspnée à la position assise ou debout. Platypnée, ça veut dire que vous respirez bien à plat.

Orthopnée, ça veut dire que vous respirez bien debout. La fréquence, elle est mesurée sur 30 secondes au minimum. Patient allongé, silencieux.

Et on regarde la cinétique abdominale. C'est comme ça qu'on va compter la fréquence respiratoire. Il faut voir l'intensité de la dyspnée.

Est-ce que c'est une dyspnée d'effort ? Il faut la compter en marche ou en étage. L'orthopnée, c'est le nombre d'oreillers nécessaires pour maintenir une respiration normale. Là, c'est les différentes échelles.

Il faut les connaître. Ça, c'est MMRC à droite. MMRC, il faut les connaître par cœur.

Là, c'est l'EVA. C'est une échelle visuelle analogique. C'est-à-dire que vous donnez au patient l'échelle du bas.

Et vous lui dites de situer sa dyspnée. Et il va la situer. Et vous allez retourner.

Et vous allez quantifier la dyspnée entre 0 et 10. Ça, c'est la NYHA. C'est la New York Heart Association.

C'est la dyspnée d'origine cardiaque. En pneumologie, on l'utilise surtout pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça, c'est l'échelle de Borg.

Elle est surtout utilisée pour les tests d'effort. Alors, vous avez les dyspnées aiguës. Il faut définir une dyspnée aiguë.

C'est une dyspnée de quelques jours. Et rechercher les signes de gravité. Ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant.

Nous, on va faire une analyse sémiologique pour ce qui nous intéresse après. Rechercher le retentissement hémodynamique et neuropsychique. La dyspnée chronique, c'est une dyspnée plus ancienne, deux semaines ou des mois, pour laquelle il faut rechercher une maladie chronique.

Une BPC ou une fibrose. Il faut caractériser cette dyspnée au niveau... Alors, quel est le parcours professionnel ? Il faut chercher, par exemple, chez les mineurs de charbon, est-ce qu'ils n'ont pas une fibrose, une silicose, qui pourrait expliquer cette dyspnée. L'horaire, la périodicité, etc.

Et puis les signes d'accompagnement. Et pour avoir une approche syndromique, et pour mettre le tout, pour mettre un nom sur ce syndrome et donner un nom à cette maladie. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les dyspnées avec signe de lutte.

Qui dit lutte, dit obstacle. Chaque fois qu'il y a une lutte, il y a un obstacle. Alors, vous avez trois types de dyspnées.

Vous savez que l'inspiration est moins longue que l'expiration. L'expiration, c'est 1,5 fois l'inspiration. Quand vous avez une dyspnée inspiratoire, l'inspiration augmente.

Et dans ce cas-là, il faut chercher un obstacle laryngé, surtout. La laryngite, la rougeole, l'inhalation de corps étranger, le dème de kouink, etc. Ou bien trachéale.

Les sténoses post-intubation ou les tubes. Si vous avez une dyspnée purement expiratoire, donc allongement du temps expiratoire, c'est au niveau des bronchioles, des petites bronches. Dans ce cas-là, c'est soit un asthme, soit une BPO, soit moins souvent la bronchiolite ou l'insuffisance cardiaque.

Et vous avez des sifflements à l'auscultation. Si vous avez une dyspnée aux deux temps, inspiratoire et expiratoire, il faut chercher soit un obstacle au niveau de la glotte, soit un obstacle trachéale. Retenez, une dyspnée aux deux temps, c'est glottique ou trachéale.

La glotte, c'est l'entrée de la trachée. Maintenant, les dyspnées sans signe de lutte. Donc il faut chercher l'un de ces trois paramètres.

Soit le cœur, soit la saturation, soit l'hémoglobine. Au niveau du cœur, vous avez soit l'insuffisance cardiaque systolique ou diastolique, soit l'insuffisance cardiaque à haut débit. Et ça veut dire que le cœur, il est normal, mais il est insuffisant pour assurer une bonne vascularisation.

Et on voit ça dans les hyperthyroïdies, dans la maladie de Pagé, dans les septicémies. Ou bien on a une modification de la saturation. Et vous avez toutes les pathologies qui sont

hypoxémiantes.

Les pathologies bronchiques, quand vous avez un bronchospasme, une atelectasie, mais dans ce cas-là, vous avez en même temps des signes de lutte et une hypoxie. Ou bien quand ça atteint le parenchyme, l'œdème, le pus, le syndrome de détresse respiratoire, les fibroses, les PID. Ou bien quand il y a une atteinte de la vascularisation pulmonaire, l'embolie pulmonaire ou l'hypertension pulmonaire.

Ou bien une baisse de l'hémoglobine, des anémies. Quand vous avez une dyspnée sans signe de lutte, le premier diagnostic auquel il faut penser, c'est une anémie faite, une émération sanguine. Sinon, parmi les dyspnées sans signe de lutte, vous avez également la modification du pH, soit une acidose métabolique avec réactivité respiratoire, avec hyperventilation, ce qu'on appelle la dyspnée du Q-small, augmentation du volume courant, soit une acidose, carrément une acidose respiratoire.

Vous avez des dyspnées neurologiques d'origine centrale ou psychique, mais c'est un diagnostic d'élimination. Là, vous avez tout un tas de syndromes qu'il faut connaître. Les quatre principales causes de la dyspnée aiguë, l'asthme, la pneumopathie, le DEM, le pneumothorax, ça, il faut le lire à tête reposée.

Les principales causes des dyspnées chroniques également, il faut les lire. Ça vous donne une approche syndromique des principales maladies pulmonaires. Là, c'est l'orientation étiologique en fonction de l'auscultation.

On a déjà vu l'auscultation. Devant une dyspnée sifflante, c'est surtout une obstruction, soit des voisines aériennes supérieures, soit inférieures. Là, on va passer à l'examen clinique.

Ça, c'est juste des rappels. On va faire juste l'inspection, la palpation et la percussion. L'auscultation, on vous l'a déjà faite, je pense, dans les cours de simulation.

On va aller rapidement. Je vous demande de m'excuser deux secondes. Est-ce que vous voyez mon diaporama ? Allô ? Quelqu'un ? Oui.

Très bien. On va passer rapidement sur l'examen clinique. C'est des choses que vous connaissez déjà.

L'examen physique respiratoire, c'est l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation. Ça, vous connaissez. L'inspection du thorax, normal.

Le thorax est en position verticale, neutre, assis ou debout. Quand il est en tripode, là, vous voyez ce patient, il est en tripode. Il s'appuie sur ses mains.

C'est pour donner un peu plus de capacité respiratoire. C'est un signe de distension thoracique. Et là, vous voyez, le thorax est distendu.

Il y a une augmentation du diamètre antéropostérieur. C'est typique du broncho-amphysème. Il a la tête rentrée dans les épaules, le buste penché en avant.

C'est pour améliorer l'action des muscles accessoires. La morphologie du thorax, c'est grossièrement symétrique. Le diamètre coronal est supérieur au diamètre antéropostérieur.

Les arcs antérieurs des côtes obliques... Antérieurs des côtes obliques... Allô ? Allô ? Oui ? Donc le rapport entre diamètre antéropostérieur transversal est de 1 sur 2. Là, ce sont des malformations qu'il faut connaître. Ça, c'est le pectus carinatum. Vous avez le pectus excavatum avec une excavation, un thorax en entonnoir.

Vous avez l'inverse, le pectus carinatum. Vous avez la syphoscoliose qu'il faut rechercher systématiquement quand vous examinez un patient. Là, vous avez la distension thoracique.

C'est le signe de Campbell. Élevation du manubrium sternal. D'accord ? Normalement, il est supérieur à 3 cm entre le manubrium et la pompe d'Adam.

Et là, quand il est inférieur à 3 cm, ça veut dire qu'il y a une distension thoracique. C'est un signe d'amphisème. Voilà, il faut bien examiner la paroi, la respiration, le dynamique de la respiration.

L'ampliation thoracique. Diminution ou augmentation des mouvements de la mobilité respiratoire. Ça, vous devez le lire.

Alors, dynamique de la respiration. Normalement, le diamètre antéropostérieur doit augmenter à l'inspiration parce qu'on fait fonctionner le diaphragme. Et une augmentation du diamètre transversal de la partie inférieure de la cage thoracique.

Là, je vais vous montrer un petit peu la respiration paradoxale. Ce qu'on appelle le signe de Hoover chez le BPCO. Normalement, vous avez une augmentation du diamètre transversal de la paroi thoracique avec un abaissement diaphragmatique et donc un gonflement du poumon.

Le signe de Hoover, c'est l'inverse. Vous avez une diminution du diamètre transversal de votre thorax. C'est un signe de distension thoracique de respiration intercostale.

D'accord ? C'est un tirage. Ça s'appelle le signe de Hoover. Bien sûr, l'aspect cutané.

Ça, je ne vous apprend rien. Donc, il faut chercher toutes les anomalies à l'inspection. Visibilité du muscle inspiratoire du cou.

Ça veut dire qu'il a un tirage. Et rechercher la turgescence jugulaire. Et vous appuyez sur le foie pour voir le reflux hépatojugulaire.

Là, je vais vous montrer juste les choses qui vont nous servir pour nos QCM et nos cas cliniques. Donc ça, palpation de la trachée. Vibration vocale.

Elles sont diminuées. Donc, vous mettez les mains à plat sur la parotte thoracique. Ça, vous savez, vu que vous faites des stages.

Vous allez faire le stage de chaleur hospitalier. Vous allez voir les vibrations vocales diminuées ou abolies quand il y a un pneumothorax, une plurésie ou une pneumonectomie. Elles sont augmentées quand il y a une condensation par enchimanteuse.

Mais le plus souvent, elles sont diminuées ou abolies. Pneumothorax ou plurésie. Crépitations neigeuses quand il y a de l'emphysème sous-cutané.

Ça, on passe. On va passer directement à la percussion. Ça va être rapide.

On va passer aux cas cliniques après. Je vous ai mis le truc sonorisé. Attendez, excusez-moi.

Ça, on passe. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Allô? Non, monsieur. Très bien.

On continue. Donc, la percussion. Vous voyez Fabien? Non, il n'y a pas de diaporama.

Ok, on va partager. Et là, vous voyez? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur.

C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Voilà, la percussion.

Alors ça, c'est la technique sophistiquée. Vous mettez la main à plat et vous tapotez sur les doigts. Mais le plus simple, c'est de taper directement sur la paroi thoracique rapidement pour comparer la droite et la gauche.

D'accord? Pour mettre en évidence l'hypersonorité ou la matité. Là, vous voyez une paroi thoracique normale. Vous avez l'espace intercostal.

Là, vous avez la plèvre. Normalement, c'est un espace vide. Il ne doit rien y avoir.

Là, vous voyez de l'air. Quand vous avez de l'air, vous avez un tampanisme. Quand vous percutez, vous avez un tampanisme.

Vous avez une diminution du murmure vésiculaire. Et une diminution ou abolition des vibrations vocales. Et là, quand vous avez un épanchement en jaune, là, vous avez une diminution des vibrations vocales.

Une diminution du murmure vésiculaire. Mais vous avez une matité à la percussion. Voilà.

Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va passer aux exercices maintenant. Ok.

Très bien. On va passer aux exos. Alors, au niveau des QCM, la plupart sont à choix simple.

Mais il peut y avoir des choix multiples. Donc réfléchissez bien. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Allô? Très bien.

Première question, c'est concernant la dyspnée. Une dyspnée avec des signes de lutte et allongement du temps inspiratoire est compatible avec quoi? Tumeur laryngé. Tumeur laryngé.

Très bien. Une anémie hémolithique, non. C'est une dyspnée par anémie.

Crise d'asthme, non. C'est un allongement du temps expiratoire. Fibrose pulmonaire, non.

C'est une hypoxie sans signe de lutte. Insuffisance cardiaque, non. C'est par hypodébie cardiaque.

Donc la tumeur laryngée, oui, parce que c'est une tumeur proximale avec allongement du temps inspiratoire. Très bien. Une dyspnée avec signe de lutte et allongement des deux temps respiratoires est compatible avec? Tumeur tracleur.

Très bien. BPCO, non. On peut le voir, mais c'est vraiment en fin de course.

En général, c'est le temps expiratoire. Crise d'asthme, pareil. Embolique pulmonaire, non.

Pneuopathie infectieuse, non plus. C'est plutôt l'hypoxie. L'embolique pulmonaire, c'est multifactoriel.

Mais l'embolique pulmonaire ne donne pas de signe de lutte. Une tumeur tracleur, oui. Parce qu'elle est en plein milieu.

Donc elle donne une dyspnée inspiratoire et expiratoire. Une dyspnée avec des signes de lutte et allongement du temps expiratoire est compatible avec quoi? BPCO. Hein? Crise d'asthme, BPCO.

Une crise d'asthme et une exacerbation de BPCO. Très bien. Embolique pulmonaire, non.

Oedème de Kwinc, non plus. C'est un allongement du temps inspiratoire. Le pneu motoraxe, non.

Le pneu motoraxe, c'est plutôt hypoxique. Parfait. Une dyspnée par désaturation en oxygène.

Sans signe de lutte. Je dis bien sans signe de lutte. Peut se voir dans une anémie, une crise d'asthme, une épiglottite, une fibrose pulmonaire ou une insuffisance cardiaque chronique.

Fibrose. Exactement. L'anémie, non.

Les anémies ne donnent pas de désaturation. La saturation reste normale. Crise d'asthme, elle peut donner une désaturation et une crise d'asthme.

Mais avec des signes de lutte. Une épiglottite, c'est des signes de lutte inspiratoires. Fibrose pulmonaire, oui, c'est une désaturation en oxygène.

Il n'y a pas d'obstacle. Donc, il n'y a pas de signe de lutte. Insuffisance cardiaque chronique, non.

Insuffisance cardiaque chronique, c'est par hypodébit cardiaque. Donc, c'est une fibrose pulmonaire. Parfait.

Alors, maintenant, les QCM sont finis. Maintenant, il va falloir me répondre. On va passer aux choses sérieuses.

Donc, c'est les cas cliniques. Un patient de 70 ans. Tabagique à 50 paquets à nez.

Consulte pour une dyspnée chronique. Survenant actuellement au moindre effort. L'inspection du thorax montre une distension thoracique et une diminution inspiratoire du diamètre thoracique transversal.

La radiographie thoracique montre un bronchophysème étendu bilatéral. Très bien. Comment s'appelle le dernier signe clinique décrit? C'est-à-dire une diminution inspiratoire du diamètre thoracique transversal.

Ça s'appelle comment? Signes de rover. Signes de rover. Très, très bien.

Donc, c'est un signe de respiration paradoxale. Alors, normalement, la palpation, la percussion et l'auscultation devraient retrouver quoi? D'abord, la palpation devrait retrouver quoi? La palpation, c'est les vibrations vocales. Elles sont comment? Abolies.

Ou diminuées, oui. Franchement diminuées. Et à droite ou à gauche? Ou les deux? Logiquement.

Deux. Oui, bien sûr. C'est bilatéral.

C'est un bronchophysème. Donc, les vibrations vocales sont diminuées, voire abolies. La percussion, vous devriez y retrouver quoi? Maturité? Non.

Tintinisme. Ben oui, c'est un tintinisme. D'accord? C'est un tonneau.

Il est plein d'air. C'est un bronchophysème. Augmentation des espaces aériens périphériques.

Donc, c'est un tintinisme. C'est de l'air. L'auscultation, le murmure vésiculaire.

Diminuées, voire abolies. Et des deux côtés. D'accord? Donc, abolition, diminution des vibrations vocales, tintinisme et abolition, diminution du murmure vésiculaire.

Parfait. OK? C'est le signe de Hoover. D'accord? Diminution du diamètre transversal à l'inspiration.

Là, vous voyez un bronchophysème. Là, vous avez l'aspect festonné au niveau du diaphragme. D'accord? Et là, vous avez une déshabitation par enchimatoïse.

Vous avez des zones qui sont très, très noires. D'accord? C'est typique de l'orphysème. Et surtout, c'est visible sur la radeau de profil.

Vous voyez que le diamètre antéropostérieur est presque égal au diamètre transversal, ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est la moitié. Et là, vous voyez une augmentation de l'espace clair rétrosternal et de l'espace clair rétrocardiaque.

C'est typique de l'orphysème. Si vous voyez ça, c'est de l'orphysème jusqu'à preuve du contraire. Un patient de 25 ans, sans antécédent, tabagique modéré, consulte pour une douleur thoracique brutale, droite, accompagnée d'une dyspnée survenue lors d'un effort physique.

Quel est le diagnostic le plus probable? 25 ans. Un pneu motoraxe. Bravo.

Excellent. C'est un pneu motoraxe droit. Alors, l'examen thoracique devrait retrouver quoi? L'inspection, d'abord.

Mais c'est pourquoi le pneu motoraxe? Hein? Parce qu'il a 25 ans. Parce qu'il a 25 ans et c'est une douleur thoracique brutale, droite. Elle n'est pas gauche.

À gauche, on pourrait penser à un problème cardiaque. Et accompagnée d'une dyspnée. Et survenue lors d'un effort physique.

Et il est tabagique modéré. C'est typique. Retenez ce tableau.

C'est le premier diagnostic à évoquer. C'est un pneu motoraxe. Typique, typique.

D'accord? Il y a d'autres diagnostics qui sont possibles. Ça peut être une dissection aortique. D'accord? Mais à 25 ans, il faut tout de suite penser à un pneu motoraxe.

Et faire, bien sûr, un examen clinique et une radiographie thoracique. L'inspection devrait retrouver quoi? Elle pourrait être normale. Mais il y a un petit signe qui pourrait vous orienter.

Une petite distanciation thoracique unilatérale. Le côté du pneu motoraxe est parfois plus grand que l'autre. Ou plus gros.

Parfois, on le voit. Quand le pneu motoraxe est important. Très bien.

La palpation. C'est-à-dire les vibrations vocales. Elles devraient être quoi? Aboli.

Aboli, oui. Du côté droit. La percussion.

Symphonisme du côté droit. Auscultation. Diminution du murmure vésiculaire du côté droit.

Ou carrément abolition, oui. Exactement. On le compare par rapport au côté gauche.

Et ça va nous donner une idée. C'est un pneu motoraxe droit, spontané, idiopathique. Retenez

bien ce tableau.

Il est typique. Inspection, distanciation hémitoracique droite. Abolition des vibrations vocales.

Tympanisme. Et abolition du murmure vésiculaire. Parfait.

Vous voyez le pneu motoraxe. Là, c'est de l'air. Normalement, on devrait voir les vaisseaux.

On devrait voir le parenchyme. Là, on ne voit rien. C'est que de l'air.

Et le poumon entier, c'est ça. C'est un moignon de poumon. Le poumon est ratatiné vers la paroi à cause de l'air qui a pénétré à l'intérieur de la plèvre.

D'accord ? En général, c'est dû à une petite rupture de bulle soupleurale. Ce qu'on appelle les blèbes. Elles se rompent.

Et donc, il y a une communication entre la plèvre et les alvéoles. Et c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle un pneu motoraxe. Et là, vous voyez le thorax.

Il est distendu par rapport à l'autre. Vous avez vu, à cause de l'air. Une patiente de 28 ans.

Alors ça, c'est un tableau que vous verrez très, très, très, très, très souvent. Surtout si vous faites de la pneumo. Une patiente de 28 ans.

Sans antécédent. Non tabagique. Consulte pour une dyspnée d'apparition progressive depuis 4 mois.

Retenez, 4 mois. Ayant fait suite à des douleurs basithoraciques droites. Avec fièvre à 38.

Perte de 10 kg en 4 mois. Et sueur nocturne. Ce téléphone est comme tableau.

La radiographie thoracique montre un épanchement liquidien de moyenne abondance de l'hémithorax droit. Quel est le diagnostic le plus probable ? La tuberculose. Laquelle ? Quel endroit ? De quel organe ? Respiratoire.

Mais ça n'existe pas la tuberculose respiratoire. De quel organe ? La radiographie thoracique. Elle montre quoi ? C'est une tuberculose, oui, mais de quoi ? La plèvre.

Oui, oui. C'est une tuberculose pleurale. D'accord ? C'est un tableau typique que vous verrez très, très souvent.

Alors, que doit retrouver l'examen clinique ? Inspection. D'abord l'inspection. L'inspection est souvent normale.

D'accord ? L'inspection est souvent normale. On va passer au plus important. La palpation.

Les vibrations vocales, elles sont comment ? Je parle des vibrations vocales, mais elles mentionnent la percussion. Elles sont diminuées au niveau de la base droite. D'accord ? Au niveau de la base, de la moitié inférieure de l'hémitorax droit.

La percussion, tu as dit une matité. D'accord. L'auscultation.

Le murmure vésiculaire, il est comment ? Il est diminué. Il est diminué. Une question subsidiaire.

Est-ce qu'on devrait entendre un frottement pleural à ce stade ? Vous avez fait l'auscultation. Est-ce qu'on devrait entendre un frottement pleural ? Le penchement est de moyenne abondance, je pense. Le frottement est de plusieurs abondances.

Exactement. On ne peut pas entendre de frottement pleural. Parce que le penchement est de moyenne abondance.

Très bien. Voilà. L'inspection, normalement, le thorax est symétrique.

C'est rare qu'il soit distendu. Diminution des vibrations vocales, matité et diminution du murmure vésiculaire. Là, vous voyez, pleurésie de moyenne abondance.

Ok ? À droite. Ça, c'est un peu plus difficile. Un patient de 65 ans, non tabagique, consulte pour une dyspnée apparue il y a un an.

C'est une dyspnée chronique, progressivement croissante, apparaissant actuellement au moindre effort, accompagnée d'une toux sèche, invalidante. L'examen des doigts retrouve un hypocratisme digital. La radiographie thoracique retrouve un syndrome interstitiel étendu, prédominant aux bases.

Quel est le diagnostic le plus probable ? Si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave. Mais c'est un tableau typique. C'est le 114 à gauche.

Là, l'hypocratisme digital ne va pas avec le tableau. Une dyspnée apparue il y a un an, progressivement croissante. Une fibrose ? Exactement.

Bravo. C'est une fibrose pulmonaire. Oui.

C'est une fibrose pulmonaire. Typique. L'auscultation, vous devez retrouver quoi ? L'auscultation, vous devriez retrouver quoi ? Si vous vous souvenez de votre TP d'auscultation.

L'augmentation des... Là, là. Il n'y a pas d'augmentation. Monsieur ? Oui ? Monsieur, on n'a pas fait TP.

Comment ? On n'a pas fait TP. Vous avez touché l'auscultation ? Non. Non, vous êtes en troisième... Ah, vous êtes en deuxième année.

Non. Pardon. Oui, oui.

Les crépitants. Les crépitants. Exactement.

On entend des crépitants. Par K9 le cours de l'auscultation. D'accord ? Vous devez le revoir.

On retrouve des crépitants à l'auscultation. C'est une gêne à l'ouverture des petites bronches. C'est une gêne à l'ouverture des petites bronches.

Très bien. Quel est le mécanisme de la dyspnée ? C'est une hypoxie. Exactement.

C'est une dyspnée par hypoxie. Bravo. Voilà.

Pour une deuxième année, je trouve ça excellent. C'est très très bien. Et voilà, c'est une image typique de fibrose pulmonaire.

Vous voyez ce syndrome interstitiel bilatéral qui prédomine aux bases et aux périphéries. D'accord ? C'est une maladie mortelle. Et il n'y a pas de traitement efficace à part la greffe de poumon.

Une patiente de 30 ans, connue allergique, consulte pour une... Alors, je vous préviens, vous n'aurez pas des questions aussi difficiles à l'examen. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Ça, c'est juste... J'aimerais que vous ayez une approche, d'accord ? Une approche très très méthodique dans votre sémilogie, dans votre approche clinique.

C'est pour ça que je vous fais tout ça. D'accord ? Les questions d'examen ne seront pas aussi compliquées. Une patiente de 30 ans, connue allergique, consulte pour une dyspnée aiguë, avec haute pression thoracique et difficulté à parler, survenue il y a trois heures après une exposition au pollen.

Elle décrit des crises similaires de moindre intensité et de résolution spontanée. Quel est le diagnostic le plus probable ? Anasme. Comment ? Anasme.

Plutôt anasme. Péréactivité bronchique. Allergie respiratoire.

Et là, des dyspnées aiguës. Alors, attendez. Début d'asme.

Que devraient retrouver l'auscultation ? Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Oui, monsieur. Que devraient retrouver l'auscultation ? Non. Peut-être, mais ce n'est pas ce qui est retrouvé principalement.

Hein ? Des sibilants. Des sibilants, exactement. Une crise d'asthme, c'est des sibilants.

Alors, quels sont les mécanismes possibles de cette dyspnée ? Réfléchissez bien. Il y en a deux. Avec les yeux expiratoires ou bien époxies.

Et ? Époxies et quoi d'autre ? Ce n'est pas la principale, l'époxie. Ce n'est pas la principale. Il y en a une autre.

Avec lutte expiratoire. C'est des signes de lutte expiratoire. Exactement.

C'est un obstacle. L'asme, c'est une obstruction. Donc, il y a des signes de lutte.

D'accord ? C'est des signes de lutte. Ah, c'est bloqué. Voilà.

Lutte respiratoire et époxie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?